

PARTO PRECIPITADO EN URGENCIAS

Gema Perú Biurrun, Diego Gil Martín, Manuel García Manero, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

El parto precipitado se define como aquel que se desarrolla de manera inesperada y que acontece en un periodo de tiempo inferior a 3 horas desde el inicio de contracciones regulares. Los profesionales que lo atiendan deben prevenir y estar atentos a las posibles complicaciones derivadas de un proceso que sucede más rápido de lo habitual:

- **Desgarros severos del canal blando:** la elevada intensidad de las contracciones uterinas impide completar una distensión perineal progresiva.
- **Atonía uterina y hemorragia postparto severa:** la musculatura del útero tiende al agotamiento postparto después de un esfuerzo brusco de alta intensidad.
- **Retención placentaria:** la escasa contractilidad del útero resulta ineficiente para completar la expulsión de restos placentarios.

EVALUACIÓN DE LA PACIENTE CON TRABAJO DE PARTO

En función del tiempo disponible, la anamnesis mínima debe incluir:

- Frecuencia de las contracciones: cada 1-2 minutos, cada 3 minutos...
- Pérdida de líquido o sangre vía vaginal: sí/no.
- Percepción de movimientos fetales habituales: sí/disminuidos/no.
- Partos previos: número, tipo y complicaciones asociadas.
- Evolución y cuidados especiales durante la gestación actual.
- Fecha estimada de parto o de última regla: para calcular la edad gestacional.

Algunos de los síntomas acompañantes habituales son náuseas, vómitos y dolor en abdomen, región lumbar o muslos.

El segundo paso es determinar la fase de parto actual:

- **Primera fase (dilatación):** desde el inicio de las contracciones hasta el borramiento y la dilatación cervical completa.
- **Segunda fase (expulsivo):** desde la dilatación completa hasta el nacimiento del recién nacido a través del canal de parto materno. Dicho descenso se puede acotar en 4 planos consecutivos (denominados planos de Hodge). Son una herramienta útil para ubicar el grado de descenso del feto en cada momento. Cuando las partes fetales guía sobrepasan las espinas ciáticas (III plano de Hodge) se confirma la vía vaginal como vía de parto inminente, ya sea de tipo instrumental o eutócico.
- **Tercera fase (alumbramiento):** separación y expulsión de la placenta.

Para ello se realiza un **tacto vaginal** que incluya:

- **Grado de borramiento cervical:** 0-100%. 0% se denomina “formado” y 100% es similar a “papel de fumar”, solo suele alcanzarse en mujeres nulíparas.
- **Dilatación cervical:** desde cerrado (no permeable a punta de dedo) hasta 10 cm (cérvix aparentemente ausente, solo se palpa la cabeza fetal en la pelvis).
- **Estática fetal:** la mayoría de fetos se colocan en posición cefálica, presentando el occipucio “en anterior” (se palpa la sutura lambdoidea en forma de “Y” entre las 10 y las 14 horarias),

por encima del III plano de Hodge.

Con esta información se decide si da tiempo a trasladar a la gestante a la zona de dilatación/paritorio para continuar allí la asistencia (altamente recomendable si se prevee la necesidad de cuidados maternos o neonatales especiales) o si se habilita la zona de urgencias para completar ahí el parto, por ejemplo ante un descenso progresivo y mantenido de la presentación fetal con el pujo materno espontáneo o ante un IV plano de Hodge (cabeza fetal coronando el periné). El traslado requiere el consentimiento verbal de la gestante.

PREPARACIÓN Y ASISTENCIA DEL PARTO VAGINAL

Material necesario

La sospecha de un parto precipitado debe ser comunicada de forma inmediata a los servicios de Ginecología-Obstetricia y Pediatría más cercanos, que pueden ayudar a ubicar el material necesario y adelantar posibles maniobras requeridas a corto plazo. Dado que los equipos de partos suelen reunir todos los elementos necesarios en un paquete estéril, sería interesante almacenar alguno de forma preventiva en la urgencia. Si no se dispone de uno, el material imprescindible incluye:

- 2 guantes estériles, 1 gorro y 1 mascarilla para la persona que atiende el parto.
- 1 tijera, 1 porta agujas y sutura reabsorbible (de 0 y de 2-0) para practicar una episiotomía medio-lateral a 45º y/o suturar el periné.
- Toallas, 1 paquete de gasas y un aspirador de secreciones nasofaríngeas fetales.
- 1 gorro y 1 manta para el recién nacido.
- Cuna térmica de reanimación neonatal. Conviene conectarla lo antes posible para que esté disponible en el primer minuto de vida del recién nacido.

La gestante debe ser colocada en decúbito supino sobre una camilla, con las caderas flexionadas y ambas piernas en abducción (posición de litotomía). La asepsia y/o rasurado del periné son opcionales.

Maniobras básicas del parto vaginal eutócico en presentación cefálica

- 1. Controlar la deflexión de la cabeza fetal en su salida a través del introito vaginal para evitar un desprendimiento brusco que desgarré el periné. Así, la mano dominante acompaña la distensión del periné por debajo de la cabeza fetal ("como si fuera el cuello de un jersey que se ajusta al introito materno") mientras la palma y los dedos extendidos de la mano no dominante acompañan por delante a la cabeza fetal que progresa. Ambas manos deben mostrarse firmes para evitar movimientos bruscos pero sin llegar a frenar la progresión fetal.
- 2. Descartar la presencia de circulares de cordón pericervicales. Una vez que la cabeza se ha desprendido completamente hay que recorrer con un dedo el perímetro del cuello para liberar con él las vueltas de cordón que presente el feto (descartar una distocia de hombros en ese momento, ver más abajo). En caso de circulares muy apretadas, deben clamparse con 2 pinzas y realizar un corte de tijera en medio para terminar de liberarlas sin traccionar de ellas en ningún momento. Si las vueltas no son apretadas y permiten la expulsión fetal completa también pueden retirarse al final de la misma.
- 3. Tracción suave que acompañe la salida de cada hombro fetal, empezando por el más accesible de los dos (habitualmente se presenta primero el hombro en posición anterior/superior). Ambas manos deben traccionar COMPLETAMENTE EXTENDIDAS y suavemente de la cabeza siguiendo el ángulo que presente el resto del cuerpo en su salida (hacia abajo para el hombro anterior, lo cual puede requerir agacharse flexionando rodillas, y

cambiar hacia arriba para el posterior, o viceversa, según el hombro presentado en primer lugar). El resto del cuerpo es expulsado a continuación sin requerir maniobras adicionales. Según se desprende, se puede sujetar el tórax del recién nacido con ambas manos por debajo de las axilas para colocarlo sobre el abdomen materno o una mesa accesorio.

- 4. Limpieza de secreciones buconasales del recién nacido con compresa. Entregarlo a la madre si no precisa cuidados adicionales por bienestar evidente, tapándolo con una manta y un gorrito que minimicen las pérdidas de calor. En caso contrario, clampar y cortar el cordón umbilical si no se ha hecho previamente y entregarlo directamente al servicio de Pediatría/cuna de reanimación.

Alumbramiento

La expulsión de la placenta debe completarse de forma espontánea en 60 minutos (manejo expectante) o de forma activa en 30 minutos (mantener una tracción suave de cordón y administrar oxitocina iv). Ante la sospecha de una expulsión parcial de placenta o persistencia de restos intrauterinos, es necesario que un ginecólogo valore la causa y el tratamiento apropiado. El manejo activo es preferible porque acorta la duración de esta fase, reduce el riesgo de hemorragia postparto y reduce la necesidad de uterotónicos. Se recomienda un bolo de 10 UI de oxitocina iv tras la expulsión del feto y mantener una perfusión de otras 10 UI en 500 cc de suero glucosado (dial-a-flow a 125 ml/h) en las siguientes 4 horas postparto.

Durante todo el alumbramiento y especialmente en los primeros minutos es importante comprobar mediante palpación transabdominal que el útero se encuentra bien contraído y que el sangrado vaginal resulta proporcionado. Ante la mínima duda se debe iniciar un masaje intrauterino bimanual vigoroso (una mano sobre el abdomen y la otra intrauterina) mientras se administra la oxitocina iv y se solicita ayuda. Se debe revisar el canal blando del parto para suturar posibles desgarros y/o la episiotomía realizada. Finalmente, se debe confirmar la integridad del esfínter rectal mediante un tacto rectal y la ausencia de compresas en vagina mediante tacto vaginal.

COMPLICACIONES

Distocia de hombros

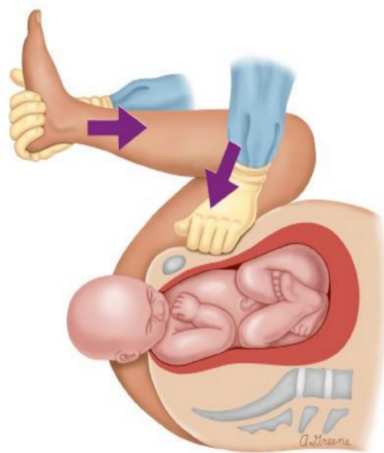
Consiste en la detención del parto espontáneo tras el desprendimiento cefálico por el impacto del primer hombro fetal presentado (el anterior contra la sínfisis del pubis o el posterior contra el promontorio sacro. Así, el hombro queda atascado en la pelvis materna, los pómulos del feto sobrepasan la vulva con lentitud y la cabeza fetal queda presionada firmemente contra el periné sufriendo, generalmente, una retracción hacia atrás (**signo de la tortuga**).

Es una urgencia obstétrica imprevisible e impredecible, pudiendo determinar altas tasas de morbilidad materna y neonatal, especialmente cuando transcurren más de 5 minutos entre la salida cefálica y la expulsión completa del cuerpo fetal.

Requiere maniobras especiales para poder desprender los hombros porque la tracción cefálica habitual resulta ineficaz, por lo que se debe avisar inmediatamente al equipo gineco-obstétrico y pediátrico disponibles junto a una serie de maniobras iniciales:

- Aplanar/horizontalizar el cabecero materno.
- Impedir el pujo materno y la tracción excesiva sobre la cabeza fetal para evitar la distensión indebida del plexo braquial.
- Contraindicar la aplicación de presión sobre el fondo uterino (maniobra de Kristeller).
- Evitar clampar o cortar una circular de cordón hasta que se haya resuelto la distocia.

- Valorar la necesidad de episiotomía, no imprescindible.
- Sondaje vesical si la vejiga se encuentra distendida.
- Hiperflexión de caderas sobre abdomen materno, 1 ayudante para cada pierna (maniobra de McRoberts).
- Presión suprapúbica.
- Una persona anotará la hora del diagnóstico, aviso a obstetras y pediatras, inicio de maniobras, etc. para trasladarlo después a la historia clínica.



Maniobra de McRoberts y presión suprapúbica. (tomado de Guía Práctica de Asistencia sobre la distocia de hombros, SEGO)

Parto de nalgas

Se trata de aquellos partos en los que la pelvis fetal es la región anatómica presentada por el feto en primer lugar. Presenta un riesgo incrementado de prolapso y/o compresión de cordón, atrapamiento último de cabeza fetal por distensión insuficiente del periné materno y traumatismo del objeto de parto por mala colocación o manipulación externa fetal, lo cual incrementa notablemente la morbilidad neonatal por esta vía de parto. Por todo ello, la actuación inmediata ante una presentación de nalgas a término de parto en urgencias implica:

- Aviso inmediato al equipo obstétrico, pediátrico y anestésico disponible.
- Traslado a quirófano para realización de cesárea urgente si no hay suficiente progresión de trabajo de parto para un expulsivo inminente.
- Si trabajo de parto avanzado y expulsivo inminente: colocación de la paciente en posición de litotomía dorsal. Cuando sea posible, retrasar pujo materno hasta que acuda un obstetra presencial. Cuando no sea posible esperar, animar al pujo materno espontáneo SIN tocar el objeto de parto hasta visualizar la salida de la primera escápula fetal (completar entonces resto de maniobras obstétricas pertinentes por un profesional experimentado).

PUNTOS CLAVE

- El parto precipitado es un evento estresante pero la mayoría de fetos se presentan en cefálica y pueden ser acompañados de forma exitosa con las maniobras básicas del parto vaginal eutócico expuestas. Es más frecuente en mujeres con un único parto vaginal previo.
- Para disminuir el riesgo de lesión del plexo fetal, la tracción cefálica debe ser suave, ejercida con las palmas de ambas manos extendidas sobre los laterales de la cabeza fetal y en la dirección que presente el resto del cuerpo durante su salida del canal de parto.

- Tras la expulsión de la cabeza fetal conviene descartar la presencia de una distocia de hombros y liberar las circulares de cordón existentes (generalmente es suficiente con la tracción digital).
- El 60% de las distocias de hombros se resuelven combinando la hiperflexión de caderas sobre el abdomen materno y la presión suprapúbica.
- Ante un parto inminente en presentación de nalgas hay que avisar al obstetra disponible y guiar los pujos maternos SIN tocar al feto hasta visionar la escápula fetal fuera de la pelvis materna.

BIBLIOGRAFÍA

- Borhart J, Voss K. Precipitous Labor and Emergency Department Delivery. Emerg Med Clin N Am 2019; 37: 265–276.
- Guía de Práctica Clínica de Asistencia al Parto Normal. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 2010.
- Guía práctica de asistencia. Parto pretérmino. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 2020.
- Guía práctica de asistencia. Distocia de hombros. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 2015.
- Guía práctica de asistencia. Parto en la presentación de nalgas a término. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 2011.